VITTA · Entrega 2 · item E2-2 (HU-03)

Formulário de análise para candidato a doação de sangue

Como as redes de doação fazem a triagem, quais regras valem hoje no Brasil e o que isso muda para o VITTA

Documento de trabalho da equipe · 19/10/2026 · regras conferidas na Portaria GM/MS nº 11.685/2026, em vigor desde 30/9/2026

> **Em uma frase**
>
> Dá para fazer a HU-03 com segurança, desde que o app seja uma **pré-análise** (as regras ficam em um arquivo com versão e data de vigência) e que a **decisão final continue sendo da triagem presencial** do hemocentro, como a própria Portaria exige.

Como ler: a seção 1 traz o resumo e as decisões que a equipe precisa tomar. As seções 2 a 4 mostram o que as redes fazem e quais são as regras. A seção 5 propõe o formulário do VITTA. A seção 6 lista o que precisa mudar nos nossos documentos. A seção 7 traz as fontes e o que não foi possível confirmar.

1. Resumo e decisões

1.1 O que a pesquisa mostrou

- **A regra mudou há poucas semanas.** A Portaria GM/MS nº 11.685/2026, publicada em 3/7/2026, reescreveu o regulamento técnico do sangue e está em vigor desde 30/9/2026. Vários prazos diminuíram: tatuagem (antes 6 a 12 meses, agora 7 dias se o local for seguro), endoscopia (6 para 4 meses), parceiro ocasional (12 para 4 meses), transfusão (12 para 4 meses) e viagem a área de malária (até 12 meses para 30 dias).
- **Os números da nossa matriz não existem nas regras.** Não foi encontrado “5 meses” para tatuagem nem “7 dias” para febre ou gripe em nenhuma fonte. Os prazos reais estão na seção 3 e a lista do que trocar nos documentos está na seção 6.
- **Nenhuma rede decide só pelo questionário.** No Brasil o questionário prévio, inclusive digital, é permitido, mas não dispensa a entrevista presencial (Art. 36, § 2º). No Canadá, o questionário do site é só informativo e, no Canadá e na Austrália, a equipe decide no local. Hemoglobina, pulso, temperatura e peso medido só existem no local.
- **O formato que se repete** é uma lista de perguntas curtas de sim ou não, cada uma com um período claro (“nas últimas 48 horas”, “nos últimos 3 meses”, “alguma vez na vida”). Quem responde “sim” recebe perguntas de acompanhamento (quando, onde, qual). Os remédios ficam em uma lista à parte, com um prazo para cada um.
- **Remédios não cabem em uma pergunta só.** A tabela da Portaria tem prazos de 48 horas a 3 anos, e alguns definitivos. Não impedem: paracetamol, dipirona, aspirina (só afeta a doação de plaquetas), losartana, diuréticos, estatinas e, em geral, antidepressivos. Impedem por um tempo: antibióticos (14 dias), anticoagulantes (2 a 7 dias), imunossupressores (12 meses), remédios de acne, queda de cabelo e próstata (1 mês a 3 anos) e PrEP/PEP (4 meses a 2 anos).
- **O que mais barra candidatos** (estudo de Fortaleza, 2012, com as regras da época): hemoglobina baixa, sobretudo em mulheres, comportamento sexual de risco, remédios, gripe, endoscopia e viagem a área de malária. O app não mede hemoglobina, mas pode avisar antes nos outros casos.

- **Pré-triagem antes da ida parece ajudar.** No piloto de teletriagem por vídeo do Hospital Israelita Albert Einstein (2021), 16% dos candidatos foram barrados antes de ir ao banco de sangue. Entre os que foram, só 3% foram barrados na triagem presencial (no histórico do serviço, de 18% a 23%). É um piloto de um só centro, sem grupo de comparação.
- **Dados de saúde e de vida sexual são dados pessoais sensíveis** na LGPD. O formulário precisa de consentimento específico, coleta mínima e exclusão junto com a conta.

1.2 Decisões que a equipe precisa tomar

Nº	Decisão	Recomendação
1	**Que regras o formulário segue?**	A Portaria 11.685/2026, que é a que vale hoje. Guardar os prazos em um único arquivo de regras, com a versão e a data de vigência, para poder mudar sem mexer no resto do código. Trocar os números da matriz e do Documento de Requisitos (seção 6).
2	**Quais resultados o app mostra?**	Quatro: apto, inapto temporário (com a data de retorno), inapto e “precisa de avaliação no hemocentro”. O quarto cobre o que a Portaria deixa para o médico (70 anos ou mais que já doou, 61 a 69 anos sem doação anterior, remédio fora da lista, “não sei”). Toda mensagem diz que a decisão final é da triagem presencial.
3	**Quais perguntas entram na primeira versão?**	As 20 marcadas “Sim” na seção 5.2; as outras 5 ficam para depois. Se faltar tempo, o mínimo seria: idade, peso, tatuagem e piercing, gripe e febre, remédios por grupo, gestação e viagem a área de malária.
4	**Quanto tempo vale o formulário (RN-003)?**	30 dias, em uma constante fácil de mudar. A data do agendamento precisa cair dentro da validade. No dia da doação, a triagem presencial repete tudo.
5	**E o sexo da pessoa?**	O cadastro não tem esse campo, mas o intervalo entre doações (2 ou 3 meses) e as perguntas de gestação dependem dele. Recomendação: uma pergunta opcional dentro do formulário e, se a pessoa preferir não informar, usar o intervalo maior (3 meses).
6	**As perguntas sobre vida sexual entram?**	Sim, porque estão entre as que mais barram candidatos. Com texto neutro (só comportamentos e datas, nunca orientação sexual) e com a opção “prefiro falar na triagem”, que leva ao resultado “precisa de avaliação”.
7	**O que guardar de dados de saúde?**	O resultado, o motivo, as datas, a versão das regras e só as respostas necessárias para calcular a data de retorno. Pedir consentimento específico para isso e apagar tudo junto com a conta (HU-02).

1.3 Depois da decisão

1. Atualizar a HU-03, as regras RN-001 a RN-004 e a matriz (E2-2) com os números reais.
2. Implementar: arquivo de regras, tabela no banco, rotas em /doadores/me/formulario e testes de valores-limite (seção 5.7).
3. Montar a tela do formulário no app (Expo Go).
4. Gerar as evidências pedidas na matriz: relatório dos testes, vídeo (apto, inapto e inapto temporário) e consulta ao banco com a data de validade.
5. Rodar de novo a coleção do RNF-002 com as rotas reais do formulário.

2. Como as redes de doação montam o formulário

2.1 No Brasil: o que a Portaria exige da triagem

Como citar: os artigos são do regulamento técnico (Anexo IV-B da Portaria de Consolidação nº 5/2017, na redação da Portaria 11.685/2026). Os “Anexos 1 a 4” são as tabelas de doenças, cirurgias, medicamentos e vacinas.

- **Quem faz a triagem:** profissional de saúde de nível superior, qualificado, sob supervisão médica, em entrevista individual, em ambiente que garanta privacidade e sigilo, com registro que possa ser rastreado (Art. 36 e § 1º).
- **Questionário prévio:** o serviço pode oferecer um questionário estruturado antes da entrevista, inclusive digital, mas o preenchimento não dispensa a avaliação presencial para tirar dúvidas, orientar e concluir a triagem (Art. 36, § 2º). É esse artigo que dá base à HU-03.
- **Antes de doar:** material informativo sobre as condições básicas, as infecções transmitidas pelo sangue e os riscos do uso de PrEP e PEP (Art. 35), e termo de consentimento assinado (Art. 34).
- **O que o serviço avalia:** 12 itens para proteger o doador (Art. 37: frequência, idade, peso, pulso, hemoglobina, história clínica, remédios, gestação e lactação, jejum, álcool, ocupação e volume) e 11 para proteger quem recebe (Art. 53: aspecto geral, temperatura, vacinas, local da punção, transfusões, infecções, doenças virais, parasitárias e bacterianas, situações de risco e cirurgias).
- **Depois da triagem:** o candidato deve ser informado do motivo e do tempo da inaptidão, e o motivo fica registrado na ficha (Art. 69). O serviço pode oferecer a autoexclusão confidencial (Art. 68, § 5º).
- **Sem discriminação:** a triagem é feita sem preconceito por orientação sexual, identidade de gênero, hábitos de vida ou profissão, sem prejuízo da segurança de quem recebe o sangue (Art. 2º, § 3º). As perguntas do VITTA devem falar de comportamentos e datas, nunca de identidade.
- **Sigilo:** as informações do doador devem ser preservadas, observada a LGPD (Art. 33).

2.2 Aplicativos e pré-triagem digital no Brasil

- **Hemovida** (Ministério da Saúde, ligado ao Conecte SUS): segundo a imprensa, localiza serviços de hemoterapia e baixa a carteira do doador. Não foi encontrada triagem de elegibilidade nele.
- **Gota de Vida** (HEMOES, Espírito Santo) e **Sangue Amigo** (Rondônia): agendamento e avisos. A notícia sobre o Gota de Vida cita um questionário de elegibilidade, mas o conteúdo dele não pôde ser consultado.
- **Projetos acadêmicos** (UTFPR, UFJF, DOE+ de Alagoas): o da UTFPR faz autotriagem em duas etapas (coleta as informações e depois filtra os aptos e os convida para o exame que comprova a aptidão) e reconhece que dado declarado pode estar errado.
- **Teletriagem por vídeo** (Hospital Israelita Albert Einstein, 2021): 288 agendamentos; em 35 (12%) a teletriagem não aconteceu por falha de áudio ou vídeo ou falta do candidato. Dos 253 avaliados, 213 (84%) foram considerados aptos e deviam doar em até 7 dias. Entre os 190 aptos que compareceram, só 6 (3%) foram barrados na triagem presencial. A entrevista foi feita por profissional, e não por questionário no aplicativo.
- Não foi encontrado aplicativo brasileiro público que devolva “apto” ou “inapto” a partir de um questionário. O VITTA ficaria entre os poucos, o que reforça o cuidado com o texto das mensagens.

2.3 Em outros países

Rede	Como o formulário é feito	O que aproveitar
EUA AABB, Donor History Questionnaire v4.0 (maio/2023, reconhecido pela FDA)	41 perguntas de sim ou não, agrupadas por período: hoje, 48 horas, 8 semanas, 3 meses, 12 meses, 2 anos, 3 anos e “alguma vez”. A pergunta sobre remédios remete a uma Lista de Medicamentos à parte (atualizada em setembro/2026). O doador lê o material educativo no mesmo dia. Fluxogramas opcionais orientam as perguntas de acompanhamento.	A organização por período. A lista de remédios separada. A frase da lista: “não pare de tomar o remédio receitado para poder doar”.
Canadá Canadian Blood Services	Sete partes: aviso de privacidade, como se sente hoje, remédios e vacinas, histórico médico, viagens, perguntas adicionais (estilo de vida, saúde sexual, exposição) e consentimento. A versão do site é só informativa. Quem responde “sim” a algo deve esclarecer antes de ir. A equipe decide no local.	A ordem das telas. O aviso de que o resultado do site não é a decisão final.
Austrália Lifeblood	Teste de elegibilidade de 2 minutos antes de agendar. Quem passa no teste pode marcar a doação. A elegibilidade final é decidida pela equipe no centro.	É a mesma ideia da HU-03: o teste libera o agendamento.
OMS (2012) modelo de questionário	Três partes: avaliação de saúde, avaliação de risco e declaração. No fim, espaço para o profissional marcar aceitar ou adiar, o prazo e o motivo.	O resultado do VITTA também precisa trazer decisão, prazo e motivo.

2.4 O que todas têm em comum

- Perguntas curtas, de sim ou não, com **uma ideia por pergunta**.
- **Período claro** no enunciado (“nos últimos 4 meses”, “alguma vez na vida”). Quem responde “sim” recebe perguntas de acompanhamento.
- Começam pelo **estado de hoje** (“você está se sentindo bem?”) e deixam as perguntas mais íntimas para o meio ou o fim, depois de explicar por que elas importam.
- **Remédios em lista à parte**, com prazo por remédio. Quem toma remédio de uso contínuo não deve parar por causa da doação.
- A resposta **não é a decisão**: o formulário organiza a informação e o profissional confirma.
- Todo resultado traz **decisão, prazo e motivo**.
- **Declaração de que respondeu com sinceridade**, consentimento e aviso de confidencialidade.
- **Informação educativa antes**: por que as respostas importam e o que fazer se algo mudar depois.

3. Regras do Brasil hoje (Portaria 11.685/2026)

As tabelas abaixo reúnem o que interessa a um formulário feito pelo próprio candidato. A Portaria diz que cada caso é avaliado pelo profissional e que as tabelas listam os “principais” casos. Os prazos são contados a partir da data indicada em cada linha. A coluna “Fonte” cita o artigo ou o anexo.

3.1 Requisitos básicos

Item	Regra	Fonte	No formulário?
Idade	De 16 anos completos até 69 anos, 11 meses e 29 dias. De 16 a 17 anos: autorização escrita do responsável a cada doação, com cópia do documento dele. Primeira doação: até 60 anos, 11 meses e 29 dias. Doador de repetição com mais de 70 anos: pode continuar após avaliação médica. Fora da faixa: só com avaliação do médico e relatório.	Art. 39	Sim (vem do cadastro)

Item	Regra	Fonte	No formulário?
Peso	Mínimo de 50 kg. Abaixo disso, só com avaliação médica e volume menor (8 mL por kg para mulher, 9 mL por kg para homem). Perda de peso sem explicação acima de 10% em 3 meses: não é selecionado.	Art. 40	Sim (peso informado)
Hemoglobina	Mulheres: 12,5 a 16,5 g/dL. Homens: 13,0 a 18,5 g/dL (ou hematócrito de 38 a 50% e de 39 a 54%).	Art. 42	Não, é medida no local
Pulso e temperatura	Pulso de 50 a 100 batimentos por minuto. Temperatura até 37 °C.	Art. 41 e 53, II	Não, são medidos no local (o formulário pergunta sobre febre)
Intervalo entre doações	Sangue total: homens a cada 2 meses, no máximo 4 por ano; mulheres a cada 3 meses, no máximo 3 por ano.	Art. 38	Sim (data da última doação)
Gestação e amamentação	Gestação: inapta até 12 semanas depois do parto ou do aborto. Amamentação: não é aceita se o parto foi há menos de 12 meses. A menstruação não impede.	Art. 45 e 46	Sim
Comida e bebida	Sem refeição gordurosa nas 3 horas antes. Quem está em jejum prolongado recebe lanche. Bebida alcoólica: esperar 12 horas.	Art. 47 e 49	Aviso do dia, não pergunta
Ocupação de risco	Quem pilota, dirige ônibus, caminhão ou trem, opera máquina de alto risco, trabalha em andaime, mergulha ou salta de paraquedas só doa se puder parar a atividade por 12 horas depois.	Art. 51	Aviso (opcional)
Alergia	Aceita se estiver sem sintomas. Asma crônica grave e choque anafilático: inapto definitivo. Tratamento de dessensibilização: esperar 72 horas.	Art. 50	Sim, em "doenças"

3.2 Tatuagem, piercing, maquiagem definitiva e procedimentos estéticos

Situação	Regra nova (Portaria 11.685/2026)	Regra antiga (ainda nas páginas de algumas redes)
Tatuagem, maquiagem definitiva, acupuntura, piercing comum, botox, preenchimento ou microagulhamento, em local em que a segurança pode ser avaliada	**7 dias** depois do procedimento	6 meses. O HEMOCE e o HEMOES, consultados em 19/10/2026, ainda mostram 6 meses a 1 ano para tatuagem. Botox: 72 horas no HEMOES e 15 dias no HEMOCE.
Os mesmos procedimentos, sem como avaliar a segurança do local ou do material	**4 meses** depois do procedimento	12 meses (Portaria 158/2016 e HEMOCE)
Piercing na boca ou na região genital	Impedido enquanto usar; **4 meses** depois de retirar, por causa do risco permanente de infecção	12 meses depois de retirar
Retirada de verruga, unha, mancha e outros pequenos procedimentos de pele	Depois da cicatrização	Depois da cicatrização

Fonte: Anexo 2 (parte A), Art. 65 e Art. 66, VII. Confirmado no Ministério da Saúde (12/8/2026), na Secretaria da Saúde do Paraná e no Hemocentro Unicamp.

Como saber se o local era "seguro"?

A Portaria e as notícias oficiais falam em local "que cumpra as normas de segurança sanitária", mas não dizem que documento o doador deve levar. A página do Paraná manda perguntar ao hemocentro.

Proposta para o formulário: perguntar (1) se o estabelecimento tem licença da vigilância sanitária e (2) se o material era descartável ou esterilizado, aberto na hora. Se a pessoa não tiver certeza, tratar como "não sei" e aplicar os 4 meses. Essas duas perguntas vêm de práticas de outras redes (Austrália e EUA), não da Portaria.

Como outras redes tratam a tatuagem

Rede	Prazo	Observação
Austrália (Lifeblood)	Sangue e plaquetas: 1 semana se a tatuagem foi feita em estúdio licenciado na Austrália; 4 meses se não foi licenciado ou foi feita fora. Piercing no corpo: 4 meses.	Página consultada em 19/10/2026. É o mesmo prazo de 7 dias da nova regra brasileira.
Canadá (Canadian Blood Services)	3 meses para tatuagem, micropigmentação, piercing, acupuntura e eletrólise.	Era 6 meses até 2018.
EUA (AABB, questionário v4.0)	O questionário pergunta sobre tatuagem e piercing no período de 3 meses. Bancos de sangue americanos citam exceção para tatuagem feita em estabelecimento regulado, com agulha estéril e tinta de uso único.	O material educativo da AABB, que detalha a exceção, não foi lido.
Reino Unido (NHSBT)	4 meses para tatuagem e piercing, segundo uma coluna de 2022 do site do NHSBT. O serviço do País de Gales usa 120 dias.	A página atual não abriu na consulta. Confirmar antes de citar.
OMS (2012)	O serviço nacional define o prazo conforme a segurança do procedimento. Se a segurança não puder ser comprovada, 12 meses depois do último procedimento.	Diretriz para os países, não é lei.

3.3 Medicamentos

O serviço avalia o remédio e também o motivo pelo qual ele foi receitado (Art. 44). Os prazos abaixo contam a partir da última dose.

Remédio ou grupo	Prazo	Observação
Antibióticos e antifúngicos	14 dias depois de parar	A infecção que motivou o uso também conta: apto 2 semanas depois do fim do tratamento e do desaparecimento dos sintomas (Art. 53, § 2º).
Corticoides em comprimido ou injeção	No mínimo 48 horas depois de parar	Depende da doença. Corticoide de uso na pele só impede se a doença impedir.
Anticoagulantes	Heparina e varfarina: 7 dias. Dabigatrana, apixabana, edoxabana, rivaroxabana e enoxaparina: 2 dias.	Avaliar o motivo da receita.
Antiplaquetários	Prasugrel: 3 dias. Ticagrelor: 7 dias. Clopidogrel e ticlopidina: 14 dias. Vorapaxar: 30 dias.	Avaliar o motivo da receita.
Aspirina e anti-inflamatórios (diclofenaco, meloxicam, piroxicam...)	Não impedem	Se tomados nos 3 dias antes, o serviço não prepara plaquetas dessa doação (Art. 44, § 3º).
Paracetamol, dipirona e parecidos	Não impedem	Nem se tomados no dia da doação.
Imunossupressores, imunobiológicos e imunomoduladores	12 meses depois de interromper	Avaliar o motivo e as sequelas.
Remédios para emagrecer (anorexígenos)	7 dias depois de interromper	

Remédio ou grupo	Prazo	Observação
Pressão e coração	Losartana, enalapril, captopril, bloqueadores de cálcio e diuréticos: não impedem. Betabloqueadores, metildopa, clonidina e bloqueadores alfa: 48 horas depois de suspender, caso a caso. Hidralazina e minoxidil oral: 5 dias. Amiodarona e outros antiarrítmicos: enquanto usar.	Doença grave do coração é outro assunto (definitivo, seção 3.5).
Psiquiátricos	Antidepressivos: não impedem, mas o médico avalia. Antipsicóticos: 7 dias depois de suspender. Ansiolíticos e remédios para dormir: só se a dose for alta.	A suspensão é sempre decisão do médico que receitou.
Hormônios	Testosterona sem receita: 4 meses depois de parar. Danazol: 6 meses. Hormônio do crescimento de origem humana: definitivo. Contraceptivos, hormônios femininos (exceto para câncer) e hormônio do crescimento sintético: não impedem.	Anabolizante ou hormônio injetável sem receita: 4 meses depois do último uso (Art. 62, § 7º). Com receita não impede, mas avalia o motivo.
Remédios que podem causar malformação no bebê	Isotretinoína, finasterida e talidomida: 1 mês. Dutasterida: 6 meses. Vismodegib: 2 anos. Acitretina e sonidegib: 3 anos. Etretinato: definitivo.	Isotretinoína é remédio de acne; finasterida, de queda de cabelo e próstata; acitretina, de psoríase.
Anticonvulsivantes	Usados para convulsão: definitivo. Outros usos: não impedem.	O Anexo 1 diz que a epilepsia libera 3 anos depois de parar o tratamento, sem crise. As duas tabelas não combinam; deixar para a triagem.
Estatinas e remédios de colesterol	Não impedem	Só se for tratamento de hiperlipidemia familiar.
PrEP e PEP (prevenção ao HIV)	Comprimido: 4 meses depois da última dose. Injetável (como cabotegravir): 24 meses depois da última aplicação.	O serviço deve informar o candidato sobre PrEP e PEP (Art. 35).
Insulina	Impede	Diabetes tipo 1 e tipo 2 com insulina são causas definitivas (Anexo 1).
Caneta ou aplicador de GLP-1 compartilhado	4 meses	Art. 66, XII. Vale para quem dividiu a caneta com outra pessoa.

3.4 Vacinas

Tipo de vacina	Exemplos	Prazo
Vírus ou bactérias vivos e atenuados	Febre amarela, tríplice viral, dupla viral, sarampo, rubéola, caxumba, varicela, BCG, dengue, pólio oral, rotavírus, febre tifoide oral	4 semanas
Inativadas, toxoides e recombinantes	Gripe injetável, hepatites A e B, tétano e dT, DTPa, coqueluche, pneumococo, meningite, HPV, herpes-zóster, vírus sincicial respiratório, cólera, pólio injetável	48 horas
COVID-19	Vetor viral, RNA mensageiro ou DNA: 7 dias. Vírus inativado ou proteína: 48 horas	7 dias ou 48 horas
Antirrábica	Vacina de cultivo celular	48 horas; 12 meses se foi depois de exposição a animal
Soro de origem animal	Imunoterapia passiva heteróloga	1 ano
Estudo clínico de vacina	Quem participou de teste de vacina	1 ano depois do fim do protocolo ou do registro da vacina, o que vier primeiro
Vacina para bloquear surto	Aplicada por causa de exposição à doença	Depende da exposição e do período de incubação

3.5 Gripe, febre, infecções e doenças

Impedem por um tempo (principais)

Situação	Prazo	Situação	Prazo
Gripe ou resfriado com febre de 38 °C ou mais	**2 semanas** depois que os sintomas somem (Art. 55)	Mononucleose	6 meses
Resfriado comum, sem essas condições	**3 dias** depois que os sintomas somem	Meningite infecciosa	6 meses depois da cura
Gripe (influenza)	2 semanas depois dos sintomas	Toxoplasmose	6 meses depois da cura
COVID-19	10 dias depois da recuperação	Leptospirose, cólera, citomegalovírus, úlcera péptica	3 meses
Dengue	4 semanas depois da cura (grave: 6 meses)	Sífilis	12 meses depois do tratamento
Chikungunya	30 dias depois da recuperação	Tuberculose	2 anos depois da cura (antes 5 anos)
Zika	120 dias depois da recuperação	Osteomielite	2 anos depois da cura
Oropouche	4 semanas depois da cura	Epilepsia	3 anos depois de parar o tratamento, sem crise
Diarreia aguda e conjuntivite	1 semana depois da cura	Herpes-zóster	6 meses depois que os sintomas somem
Herpes simples (labial ou genital)	Depois que as lesões somem	Caxumba, rubéola, sarampo, varicela	2 semanas depois da cura

Situação	Prazo	Situação	Prazo
Infecção bacteriana comum (sinusite, amigdalite, otite, infecção urinária baixa)	2 semanas depois do fim do tratamento	Alergia (urticária, rinite, dermatite)	Na fase aguda e durante o tratamento
Lesão de pele no local da picada	Até a cura	Atraso menstrual	Até afastar gravidez

Fonte: Anexo 1 (parte B) e Art. 53, 55 e 61. Zika e oropouche também exigem 30 dias depois do último contato sexual com quem teve a doença nos 90 dias anteriores. Para chikungunya, quem viajou a região com epidemia ou veio de lá também espera 30 dias.

Impedem para sempre (principais, Anexo 1, parte A)

- **Infecções:** HIV, hepatites B e C, HTLV; hepatite viral depois dos 13 anos (exceto hepatite A aguda); doença de Chagas; hanseníase; brucelose; babesiose; leishmaniose visceral; malária por P. malariae.
- **Câncer:** melanoma e câncer do sangue (leucemia, linfoma, mieloma). Os demais: 5 anos depois do fim do tratamento, em remissão e sem doença ativa. Não impedem: carcinoma basocelular de pele e carcinoma in situ do colo do útero.
- **Coração, vasos e pulmão:** AVC; doença cardiovascular grave (coronária, angina, arritmia grave, insuficiência cardíaca, valvulopatia, aneurisma não corrigido, trombose recorrente, trombofilia); doença pulmonar grave (enfisema, DPOC, embolia pulmonar); asma crônica grave; anafilaxia.
- **Metabolismo e hormônios:** diabetes tipo 1 e tipo 2 com insulina; síndrome de Cushing, hipopituitarismo, tireotoxicose da doença de Graves e outras. O HEMOES ainda lista Hashimoto como definitivo; a lista da Portaria não cita.
- **Fígado, intestino, rim e sangue:** cirrose, hepatopatia crônica, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, pancreatite crônica, alcoolismo crônico com lesão do fígado; doença renal crônica; doenças hemorrágicas.
- **Outras:** esclerose múltipla e outras doenças do sistema nervoso; doença psiquiátrica ou deficiência intelectual que tire a capacidade legal; doenças autoimunes que afetam mais de um órgão (lúpus, artrite reumatoide); psoríase extensa; pênfigo foliáceo; reação grave em doação anterior; Creutzfeldt-Jakob e seus fatores de risco; transplantes.

Sintomas que a entrevista deve sempre perguntar (Art. 56, parágrafo único): perda de peso sem explicação, suores noturnos, ínguas por mais de 30 dias, febre sem explicação por mais de 10 dias, tosse persistente ou falta de ar, diarreia persistente.

3.6 Cirurgias, exames e dentista

Prazo	Procedimentos (Anexo 2)
Para sempre	Cirurgia cardíaca; gastrectomia total; pneumectomia ou lobectomia; esplenectomia (exceto depois de trauma); transplante de órgãos, tecidos e terapia gênica.
12 meses	Politrauma; colectomia; esplenectomia depois de trauma; nefrectomia; ressecção de aneurisma.
6 meses	Colecistectomia; histerectomia; laminectomia; artrodese de coluna; tireoidectomia; nódulo de mama; vagotomia super-seletiva; cirurgia bariátrica (o Paraná acrescenta: com peso estável); cirurgias ortopédicas; cirurgia plástica com anestesia peridural, raquimedular ou geral.
4 meses	Cirurgias laparoscópicas; **qualquer endoscopia ou colonoscopia** (Art. 67, § 3º; antes 6 meses).
3 meses	Apendicectomia; hemorroidectomia; hernioplastia; ressecção de varizes; cirurgia plástica com anestesia local; amigdalectomia.
1 mês	Litotripsia (nefrolitotomia extracorpórea).
Depois da alta ou da cicatrização	Cirurgia de miopia ou catarata (alta do oftalmologista); retirada de verrugas, unhas, manchas e outros pequenos procedimentos de pele (cicatrização).
Dentista: 1 dia	Procedimento sem anestesia e sem sangramento (pequena cárie, ajuste de aparelho).
Dentista: 3 dias	Limpeza de tártaro e outros procedimentos com anestesia local (obturação).

Prazo	Procedimentos (Anexo 2)
Dentista: 7 dias	Extração; tratamento de canal, drenagem de abscesso, gengivite e cirurgia com anestesia local (7 dias depois do procedimento ou do fim do anti-inflamatório).
Dentista: 1 mês	Cirurgia odontológica com anestesia geral, depois do fim do tratamento.

3.7 Comportamento de risco, drogas e infecções sexualmente transmissíveis

As regras tratam de comportamentos, não de identidade. Na Portaria, as situações de 4 meses valem para a pessoa e também para os parceiros sexuais dela.

Situação	Prazo	Fonte
Relação sexual com parceiro ocasional ou desconhecido	**4 meses** depois (antes 12 meses)	Art. 66, II
Início de relação com parceiro novo	4 meses, contados do primeiro contato sexual	Art. 66, IV
Relação sexual em troca de dinheiro ou de drogas	4 meses	Art. 66, I
Vítima de violência sexual	4 meses	Art. 66, III
Relação sexual com pessoa com HIV, hepatite B ou C ou outra infecção de transmissão sexual e pelo sangue	4 meses	Art. 66, V
Parceiro de paciente em hemodiálise ou que recebeu transfusão	4 meses	Art. 66, VIII
Preso ou confinado fora de casa por mais de 72 horas	4 meses	Art. 66, VI
Acidente com material biológico em mucosa ou pele machucada	4 meses	Art. 66, IX
Transfusão de sangue ou de componentes	4 meses (antes 12 meses)	Art. 66, X
PrEP ou PEP	4 meses depois da última dose; PrEP injetável: 2 anos	Art. 66, XI
Compartilhou aplicador de GLP-1	4 meses	Art. 66, XII
Infecção sexualmente transmissível (qualquer uma)	12 meses depois da cura; infecções repetidas: definitivo	Art. 64
Droga injetável ilícita; seringa ou agulha compartilhada; marcas de uso repetido nos braços	**Definitivo**	Art. 62, § 3º e § 4º; Art. 63
Cocaína ou crack inalados	12 meses depois do último uso	Art. 62, § 5º
Maconha	12 horas	Art. 62, § 6º
Anabolizante ou hormônio injetável sem receita	4 meses depois do último uso	Art. 62, § 7º
Bebida alcoólica	12 horas	Art. 49
Alcoolismo crônico com lesão no fígado	Definitivo	Art. 48

3.8 Viagens e malária

Situação	Prazo	Fonte
Febre ou suspeita de malária nos últimos 30 dias	30 dias	Art. 57, I
Esteve em município de área de malária, ou veio de lá	30 dias depois do deslocamento (antes, até 12 meses)	Art. 57, II
Atividade em mata, bosque ou floresta	30 dias	Art. 57, III
Já teve malária	Depois da cura: P. falciparum, 12 meses; P. vivax e P. ovale, 3 anos; P. malariae, definitivo	Art. 58
Região com surto, ou com doença que não existe onde a pessoa mora	30 dias depois do deslocamento, salvo regra própria da doença	Art. 53, § 3º
Contato em casa com barbeiro em área de doença de Chagas, ou diagnóstico	Definitivo	Art. 59
Creutzfeldt-Jakob: hormônio de crescimento humano, enxerto de dura-máter, ou transfusão no Reino Unido, na Irlanda ou na França entre 1980 e 2001	Definitivo	Art. 60

O Ministério da Saúde informa que o teste de malária (NAT Plus, da Fiocruz) passou a ser feito em todas as doações, o que explica a redução do prazo.

4. O que mais barra candidatos na prática

O estudo de Fortaleza (Vieira e outros, Rev. enferm. UFPE, 2015) analisou 27.522 candidatos de um hemocentro público entre julho e dezembro de 2012: 20.577 (74,8%) foram aptos e **6.945 (25,2%) foram barrados** na triagem clínica. As regras eram as da Portaria 1.353/2011, diferentes das de hoje, então vale como ordem de grandeza. Os percentuais abaixo foram calculados a partir das contagens do artigo, sobre as 6.945 recusas.

Motivo da recusa	Candidatos	Parte das recusas
Hemoglobina ou hematócrito abaixo do aceitável	975	14,0%
Relação sexual recente (parceiro novo)	637	9,2%
Relação sexual com mais de três parceiros por ano	619	8,9%
Relação sexual com parceiro desconhecido nos últimos 12 meses	451	6,5%
Uso de medicamentos	443	6,4%
Residência ou viagem a zona de malária	344	5,0%
Estado gripal	306	4,4%
Endoscopia ou procedimento parecido	284	4,1%
Feridas no corpo	231	3,3%
Jejum prolongado	218	3,1%
Outros motivos (vacina recente, tatuagem, piercing, maquiagem definitiva, doenças crônicas, pouco repouso, pressão alta...)	2.437	35,1%

- **Mulheres:** a hemoglobina baixa foi de longe o primeiro motivo (843 de 2.935 recusas, 29%). O artigo relaciona isso ao pouco ferro na alimentação e ao fluxo menstrual. **Homens:** o primeiro motivo foi relação sexual com mais de três parceiros por ano (556 de 4.010 recusas, 14%).

- **Jovens:** 54% das recusas (3.763) foram de pessoas de 16 a 29 anos.
- **Jejum** barrou 218 pessoas por falta de informação (muita gente acha que deve ir sem comer). Um aviso simples antes da ida (“coma antes de doar”) evita isso. Esse tipo de dica cabe na Central de Informações (HU-10).
- Não foram lidos outros estudos que existem (Brasília 2018 a 2022, Espírito Santo, São Paulo, Acre). Ver seção 7.

5. Proposta para o formulário do VITTA

5.1 Princípios

- **Dizer logo no começo** que é uma pré-análise e que a decisão final é da triagem do hemocentro.
- **Uma ideia por pergunta**, com o período no enunciado e exemplos para os termos médicos (“anticoagulante, como varfarina ou rivaroxabana”).
- Mostrar as **perguntas de acompanhamento só quando a resposta for “sim”**.
- Oferecer “não sei” ou “prefiro falar na triagem” onde a pessoa pode não saber ou não querer escrever. Essas respostas viram “precisa de avaliação”, **nunca “apto”**.
- **Nunca perguntar orientação sexual ou identidade de gênero.** Só comportamentos e datas (Art. 2º, § 3º).
- Todo resultado traz **motivo, prazo e próximo passo**. A data de retorno aparece em dia/mês/ano e o motivo fica no perfil (HU-03, cenário 2).
- Nunca pedir para parar um remédio. Texto sugerido: “Não pare um remédio receitado só para poder doar.”

5.2 Perguntas sugeridas

São 25 perguntas em 10 blocos. A última coluna indica se entra na primeira versão. As datas pedem só dia, mês e ano. As regras completas de cada prazo estão na seção 3.

Nº	Pergunta e respostas	O que acontece	Fonte	1ª versão
Bloco 1 · Como você está hoje				
1	**Você está se sentindo bem e com saúde hoje?** Sim / Não	Não: inapto temporário, sem data (“volte quando estiver bem”).	Art. 53, I	Sim
2	**Nos últimos dias, você teve gripe, resfriado, febre ou tosse?** Não / Sim. Se sim: teve febre de 38 °C ou mais? E em que dia os sintomas acabaram? (data ou “ainda tenho”)	Ainda com sintomas: inapto até acabarem. Com febre de 38 °C ou mais: data do fim dos sintomas + 14 dias. Sem febre: + 3 dias.	Art. 55; Anexo 1 B	Sim
3	**Teve, sem explicação, algum destes sinais:** febre por mais de 10 dias; perda de mais de 10% do peso em 3 meses; suores noturnos; ínguas por mais de 30 dias; tosse ou falta de ar que não passa; diarreia que não passa? Não / Sim	Sim: “precisa de avaliação no hemocentro”.	Art. 40, § 2º; Art. 56	Sim
Bloco 2 · Dados básicos				
4	**Idade** (já vem do cadastro). Se tiver 61 anos ou mais: já doou sangue antes? Sim / Não	Menos de 16: inapto por idade. 16 e 17: pode, com aviso da autorização escrita do responsável. 18 a 60: segue. 61 a 69: se já doou, segue; se nunca doou, avaliação. 70 ou mais: se já doou, avaliação (doador de repetição, com médico); se nunca doou, inapto por idade.	Art. 39	Sim

Nº	Pergunta e respostas	O que acontece	Fonte	1ª versão
5	**Qual é o seu peso, em kg?** Número	Menos de 50: inapto por peso (em casos especiais o médico pode aceitar, com volume menor). 50 ou mais: segue.	Art. 40	Sim
6	**Quando foi a sua última doação de sangue?** Nunca / data. Para o intervalo: Feminino / Masculino / Prefiro não informar	Intervalo mínimo de 2 meses (homens) ou 3 meses (mulheres). Sem informar o sexo: usa 3 meses.	Art. 38	Sim
Bloco 3 · Tatuagem, piercing e procedimentos estéticos				
7	**Nos últimos 4 meses, você fez tatuagem, maquiagem definitiva, piercing, acupuntura, botox, preenchimento ou microagulhamento?** Não / Sim. Se sim: qual e em que data; o local tinha licença da vigilância sanitária e usou material descartável ou esterilizado? (sim / não / não sei); o piercing é na boca ou na região genital? (ainda uso / já retirei em [data] / não)	Local seguro: data + 7 dias. “Não” ou “não sei”: data + 4 meses. Piercing na boca ou genital: inapto enquanto usar; data da retirada + 4 meses.	Anexo 2; Art. 65 e 66, VII	Sim
Bloco 4 · Remédios, vacinas e tratamentos				
8	**Você usa, ou usou recentemente, algum destes remédios?** (marcar todos) Antibiótico ou antifúngico · corticoide em comprimido ou injeção · anticoagulante · antiplaquetário (como clopidogrel) · imunossupressor ou imunobiológico · isotretinoína (acne) · finasterida ou dutasterida · acitretina (psoríase) · antipsicótico · remédio para emagrecer · testosterona ou anabolizante injetável sem receita · PrEP ou PEP · insulina · outro · nenhum Para cada um: data da última dose ou “ainda uso”	Prazo da seção 3.3 a partir da última dose. “Ainda uso”: inapto enquanto usar, com o aviso de não parar o remédio por causa da doação. Insulina: inapto. “Outro”: avaliação, com campo para o nome.	Art. 44; Anexo 3	Sim
9	**Nos últimos 4 meses, compartilhou caneta ou agulha de aplicação (por exemplo, caneta de GLP-1) com outra pessoa?** Não / Sim e quando	Data + 4 meses.	Art. 66, XII	Depois
10	**Tomou alguma vacina nos últimos 30 dias?** Não / Sim. Se sim: tipo (viva, como febre amarela, tríplice viral ou varicela · inativada, como gripe injetável, hepatite, tétano ou HPV · COVID-19 · antirrábica · não sei) e data	Viva: + 4 semanas. Inativada: + 48 horas. COVID-19: + 7 dias. Antirrábica: + 48 horas, ou + 12 meses se foi depois de exposição a animal. “Não sei”: avaliação.	Anexo 4	Sim
Bloco 5 · Cirurgias, exames e dentista				
11	**Nos últimos 12 meses, fez cirurgia, endoscopia, colonoscopia ou outro procedimento invasivo?** Não / Sim. Se sim: qual (lista da seção 3.6) e a data	Prazo da seção 3.6 a partir da data. Cirurgia de inaptidão definitiva: inapto. “Outra”: avaliação.	Art. 67; Anexo 2	Sim
12	**Nos últimos 30 dias, fez tratamento no dentista?** Não / Sim. Se sim: tipo (sem anestesia · limpeza ou obturação · extração, canal ou cirurgia com anestesia local · anestesia geral) e data	1 dia, 3 dias, 7 dias ou 1 mês a partir da data, conforme o tipo.	Anexo 2 B	Sim
13	**Nos últimos 4 meses, recebeu transfusão de sangue ou de componentes do sangue?** Não / Sim e quando	Data + 4 meses.	Art. 66, X	Sim

Nº	Pergunta e respostas	O que acontece	Fonte	1ª versão
Bloco 6 · Doenças e condições				
14	**Algum médico já disse que você tem ou teve:** (marcar todos) Hepatite depois dos 13 anos (exceto hepatite A) · HIV/aids · HTLV · doença de Chagas · câncer · AVC · doença grave do coração ou das artérias · diabetes tipo 1 ou com insulina · epilepsia · doença renal crônica · doença grave do pulmão ou asma grave · doença autoimune que afeta mais de um órgão · doença do sangue ou da coagulação · hanseníase · outra doença crônica · nenhuma	Condição definitiva da seção 3.5: inapto. Câncer: pergunta quando terminou o tratamento; melanoma e câncer do sangue: inapto; outros com menos de 5 anos de remissão: inapto temporário; basocelular de pele e in situ de colo do útero não impedem. Epilepsia e “outra doença crônica”: avaliação.	Anexo 1 A	Sim
15	**Nos últimos 12 meses, teve sífilis, gonorreia ou outra infecção sexualmente transmissível?** Não / Sim e data da cura	Data da cura + 12 meses (sífilis: 12 meses depois do tratamento). Infecções repetidas ficam para a triagem.	Art. 64	Sim
Bloco 7 · Situações de risco (sensíveis; sempre com a opção “prefiro falar na triagem”)				
16	**Nos últimos 4 meses, você ou seu parceiro ou parceira começou uma relação nova ou teve relação com parceiro ocasional ou desconhecido?** Não / Sim e data / Prefiro falar na triagem	Parceiro novo: data do primeiro contato + 4 meses. Ocasional ou desconhecido: data do último contato + 4 meses. “Prefiro falar”: avaliação.	Art. 66, II e IV	Sim
17	**Nos últimos 4 meses, aconteceu algum destes casos com você ou com seu parceiro ou parceira?** (marcar) Relação sexual em troca de dinheiro ou drogas · relação com pessoa com HIV, hepatite B ou C ou outra infecção de transmissão sexual e pelo sangue · violência sexual · parceiro de pessoa em hemodiálise ou que recebeu transfusão · nenhum · prefiro falar na triagem	Data + 4 meses. “Prefiro falar”: avaliação.	Art. 66, I, III, V e VIII	Sim
18	**Nos últimos 4 meses, ficou preso ou confinado fora de casa por mais de 72 horas, ou teve acidente com material biológico (sangue de outra pessoa em mucosa ou pele machucada)?** Não / Sim e quando	Data + 4 meses.	Art. 66, VI e IX	Depois
19	**Uso de drogas.** Droga injetável ilícita, alguma vez? · cocaína ou crack inalados nos últimos 12 meses? · maconha nas últimas 12 horas? Sim / Não e data	Droga injetável: inapto (definitivo). Cocaína ou crack: data do último uso + 12 meses. Maconha: + 12 horas.	Art. 62 e 63	Sim
Bloco 8 · Viagens e malária				
20	**Nos últimos 30 dias, esteve em município de área de malária, em mata, bosque ou floresta, ou teve febre com suspeita de malária?** Não / Sim e data da volta	Data da volta + 30 dias.	Art. 57	Sim
21	**Já teve malária?** Não / Sim: tipo (falciparum · vivax ou ovale · malariae · não sei) e data da cura	Falciparum: cura + 12 meses. Vivax ou ovale: cura + 3 anos. Malariae: inapto. “Não sei”: avaliação.	Art. 58	Depois
22	**Nos últimos meses, teve dengue, chikungunya, zika, oropouche ou COVID-19?** Não / Sim: qual e data da recuperação	Dengue: + 4 semanas (grave: + 6 meses). Chikungunya: + 30 dias. Zika: + 120 dias. Oropouche: + 4 semanas. COVID-19: + 10 dias.	Anexo 1 B	Depois
Bloco 9 · Gestação e amamentação (só para quem informou sexo feminino ou preferiu não informar)				
23	**Está grávida, teve parto ou aborto nos últimos 3 meses, ou amamenta bebê com menos de 12 meses?** Não / Sim e data do parto ou do aborto	Grávida: inapta. Parto ou aborto: data + 12 semanas. Amamentando bebê com menos de 12 meses: inapta até ele completar 12 meses.	Art. 45	Sim

Nº	Pergunta e respostas	O que acontece	Fonte	1ª versão
Bloco 10 · Para terminar				
24	**Você pilota, dirige ônibus, caminhão ou trem, opera máquina de alto risco, trabalha em andaime, mergulha ou salta de paraquedas, e não pode parar por 12 horas depois de doar?** Sim / Não	Sim: aviso para falar na triagem (não bloqueia).	Art. 51	Depois
25	**Declaração e consentimento:** respondi com sinceridade, entendi que a decisão final é da triagem presencial e autorizo o VITTA a guardar estas respostas para esta finalidade. Marcar para enviar	Obrigatória para enviar. Sem marcar, o formulário não é enviado (cenário 4 da HU-03).	LGPD, Art. 11, I	Sim

5.3 Resultados e cálculo da data de retorno

Resultado	Quando acontece	O que o app faz
Apto	Nenhuma resposta gera impedimento, dúvida ou avaliação.	Libera o agendamento. Mensagem: “Pelas suas respostas, você pode agendar a doação. A decisão final é da triagem no hemocentro.” Guarda data e hora do preenchimento e a validade.
Inapto temporário	Há pelo menos um impedimento com prazo.	Bloqueia o agendamento até a data de retorno (a mais distante entre os prazos). Mostra o motivo e a data.
Inapto	Há impedimento sem prazo: condição definitiva da lista, droga injetável, menos de 16 anos, 70 anos ou mais sem doação anterior.	Bloqueia o agendamento. Mensagem acolhedora, só com o motivo, e orientação para conversar com o hemocentro.
Precisa de avaliação no hemocentro	Há resposta que a Portaria deixa para o médico (70 anos ou mais que já doou, 61 a 69 anos sem doação anterior, remédio “outro”, “não sei”, “prefiro falar na triagem”) e nenhum impedimento firme.	Libera o agendamento com aviso de que a triagem vai avaliar aquele ponto.

Ordem de prioridade quando há vários: inapto, depois inapto temporário (vale a data mais distante), depois avaliação, depois apto.

Como contar os prazos:

- Prazos em dias ou horas (“7 dias”, “48 horas”): conta a partir do dia do fato, e a pessoa pode doar a partir da data calculada. A Portaria não diz se o último dia já vale; confirmar com um hemocentro.
- Prazos em meses (“4 meses”, “12 meses”): mesmo dia do mês, 4 ou 12 meses depois.
- Prazos “depois dos sintomas”, “depois da última dose”, “depois da retirada” ou “depois da cura”: conta a partir da data que a pessoa informa. Se ainda não terminou, não há data: “volte quando terminar” e o formulário é refeito.

5.4 Validade do formulário (RN-003)

Nenhuma regra fixa quanto tempo vale um questionário prévio. No piloto do Einstein, quem foi aprovado na teletriagem devia doar em até 7 dias. No VITTA, qualquer coisa nova (tatuagem, gripe, parceiro novo) muda o resultado, então um prazo curto é mais seguro.

- **Recomendação: 30 dias**, em uma constante fácil de mudar. A data do agendamento precisa cair dentro da validade; se não cair, o app pede para refazer.
- No agendamento, perguntar: “Desde que você respondeu o formulário, aconteceu algo (tatuagem, doença, remédio, vacina)?”. Se sim, refazer.

- No dia da doação, a triagem presencial repete tudo, como a Portaria exige.

5.5 Como guardar as regras e as respostas

- **Um arquivo único de regras**, com a versão (por exemplo “2026-09-30”): cada regra tem a pergunta que a dispara, o prazo, a partir de quando conta, o resultado, o artigo da Portaria e a data de vigência. As regras mudam: a Anvisa está atualizando a RDC 34/2014 e emitiu a Nota Técnica 42/2026 para a transição, e as redes aplicam a nova Portaria em ritmos diferentes.
- **Cada formulário guarda a versão das regras** com que foi calculado. Assim, uma mudança de regra não altera o histórico.
- **No banco:** data e hora do preenchimento, validade, resultado, data de retorno, códigos dos motivos, versão das regras e as respostas necessárias para recalcular.
- **Rotas:** enviar e consultar o último formulário em /doadores/me/formulario. O guarda do RNF-002 já cobre /doadores/:id/formulario.

5.6 LGPD e sigilo

Esta parte é uma leitura da lei para orientar o projeto. Não substitui orientação jurídica.

- Dado “referente à saúde ou à vida sexual” é **dado pessoal sensível** (LGPD, Art. 5º, II).
- A base legal mais simples para o VITTA é o **consentimento “de forma específica e destacada, para finalidades específicas”** (Art. 11, I). A hipótese de “tutela da saúde” (Art. 11, II, f) vale só para procedimento feito por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária, o que não é o caso do app.
- **Necessidade:** coletar só o que serve para calcular o resultado (Art. 6º, III). Evitar campo de texto livre sobre saúde.
- **Compartilhamento:** não enviar as respostas ao hemocentro (HU-04, integração por API) sem consentimento próprio e específico.
- **Exclusão:** apagar o formulário junto com a conta (HU-02 e RN-010).
- **Acesso:** só o próprio doador vê o formulário (RNF-002, já testado para /doadores/:id/formulario).
- A Portaria também manda o serviço de hemoterapia manter sigilo (Art. 33). Isso vale para o hemocentro; no VITTA, vale como boa prática.

5.7 Valores-limite para os testes automáticos

A matriz (E2-2) pede testes nos limites das regras. Com os prazos atuais, sugere-se:

Regra	Passa	Barra	Observação
Idade	16 anos; 60 anos; 69 anos (se já doou antes)	15 anos; 70 anos sem doação anterior	70 anos ou mais que já doou, ou 61 a 69 anos sem doação anterior: “avaliação”.
Peso	50 kg	49 kg	Testar também 49,9 kg.
Tatuagem em local seguro	7 dias depois	6 dias depois	Local seguro = licença da vigilância sanitária e material descartável ou esterilizado.
Tatuagem sem segurança ou “não sei”	4 meses depois	1 dia antes dos 4 meses	Substitui os valores 4 e 5 meses da matriz.
Piercing na boca ou genital, já retirado	4 meses depois da retirada	1 dia antes	Se ainda usa: barra sempre.
Gripe ou resfriado com febre de 38 °C ou mais	14 dias depois do fim dos sintomas	13 dias depois	Substitui os valores 6 e 8 dias da matriz.
Resfriado comum sem febre	3 dias depois do fim dos sintomas	2 dias depois	
Parceiro novo ou ocasional	4 meses depois	1 dia antes	
Antibiótico	14 dias depois da última dose	13 dias depois	
Parto ou aborto	12 semanas (84 dias) depois	83 dias depois	
Resposta obrigatória em branco	Todas respondidas	Uma sem resposta	Mensagem: “Responda todas as perguntas obrigatórias para continuar.”

6. O que muda nos nossos documentos

Item	Está nos documentos	Regra atual	O que fazer
Tatuagem e piercing (matriz E2-2)	5 meses. Teste de limite com 4 e 5 meses.	7 dias (local seguro) ou 4 meses (sem como avaliar). Piercing na boca ou genital: 4 meses depois de retirar. Antes: 6 a 12 meses. Nenhuma fonte usa 5 meses.	Trocar os prazos e pedir o local no formulário. Testes: 6 e 7 dias; 1 dia antes e 4 meses.
Febre e gripe (matriz E2-2)	7 dias. Teste de limite com 6 e 8 dias.	Gripe ou resfriado com febre de 38 °C ou mais: 2 semanas depois dos sintomas. Resfriado comum: 3 dias.	Trocar os prazos e pedir a febre e a data do fim dos sintomas. Testes: 13 e 14 dias; 2 e 3 dias.
Idade	16 a 69 anos	Igual. Também: primeira doação só até 60 anos; 16 e 17 anos com autorização escrita; 70 ou mais só doador de repetição, com médico.	Acrescentar esses casos e a pergunta “já doou antes?” na HU-03. Manter o teste 15, 16, 69 e 70.
Peso	50 kg ou mais	Igual. Abaixo de 50 kg o médico pode aceitar com volume menor. Perda de mais de 10% do peso em 3 meses barra.	Acrescentar a pergunta de perda de peso.

Item	Está nos documentos	Regra atual	O que fazer
Resultado “apto” (HU-03, cenário 1; RN-001)	“Você está apto(a) para realizar doações.”	Só a triagem presencial confirma (Art. 36, § 2º).	Mudar o texto para “pelas suas respostas, você pode agendar” e criar o resultado “precisa de avaliação”.
Critérios da HU-03	Quatro: idade, peso, tatuagem e piercing, febre e gripe. O cenário 2 cita também cirurgia e remédios.	A Portaria tem muito mais: remédios, vacinas, cirurgias, viagem, risco sexual, gestação.	Escolher o escopo (decisão 3) e atualizar a HU-03 e o cenário 2.
Validade (RN-003)	“Calculada com base nas respostas.”	Nenhuma regra fixa o prazo de um questionário prévio.	Definir o prazo (decisão 4) e escrever na RN-003.
Menores de 18 anos	O cadastro do Caso de Uso fala em 18 anos ou mais.	16 e 17 anos podem doar com autorização escrita do responsável a cada doação (Art. 39, § 1º).	Manter o cadastro sem trava de 18 anos (como está hoje) e avisar sobre a autorização.

7. Fontes e limites da pesquisa

7.1 O que não foi possível confirmar

- **Não foi encontrada a ficha de triagem de nenhum hemocentro brasileiro** (a busca por modelos só retornou páginas de critérios). As perguntas da seção 5 foram derivadas da Portaria e comparadas com os modelos da AABB, do Canadá e da OMS.
- **As regras estão em transição.** A Portaria vale desde 30/9/2026, mas a Anvisa ainda está atualizando a RDC 34/2014 (fase final de análise de impacto) e emitiu a Nota Técnica 42/2026. Em 19/10/2026, as páginas do HEMOES e do HEMOCE ainda traziam os prazos antigos, enquanto o Hemocentro Unicamp e o Paraná já traziam os novos. Antes da entrega final, conferir de novo.
- **Não foram abertos:** o questionário do aplicativo Gota de Vida; o artigo do Brazilian Journal of Infectious Diseases sobre tatuagem e risco de infecção (o site retornou erro); a página atual do NHSBT; as páginas da Lifeblood sobre remédios; o material educativo da AABB; os estudos de Brasília, Espírito Santo, São Paulo e Acre sobre motivos de inaptidão.
- **Fontes secundárias:** as informações sobre o Hemovida, os projetos acadêmicos e a exceção da tatuagem nos EUA vêm de resumos de notícias e sites de bancos de sangue, não dos documentos oficiais.
- **Duas tabelas da Portaria não combinam entre si** (epilepsia, seção 3.3). Casos assim ficam para a triagem presencial.
- O Art. 11 da LGPD foi lido em uma cópia (lgpd-brasil.info), porque o site do Planalto não abriu. Os Art. 5º e 6º não foram conferidos no texto nesta consulta. Conferir no texto oficial antes de citar no trabalho.
- Este documento não é orientação médica nem jurídica.

7.2 Fontes (páginas consultadas em 19/10/2026)

1. Portaria GM/MS nº 11.685/2026 (DOU, 3/7/2026, Edição 123-D): texto completo, Anexo IV-B e Anexos 1 a 4. https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-11.685-de-2-de-julho-de-2026-716746858
2. Ministério da Saúde, 12/8/2026: novas regras, doadores acima de 70 anos, tatuagem, endoscopia, malária. https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias-ms/2026/agosto/com-novas-regras-do-ministerio-da-saude-pessoas-com-mais-de-70-anos-poderao-continuar-a-doar-sangue
3. Anvisa, 16/7/2026: vigência em 30/9/2026, Nota Técnica 42/2026 e RDC 34/2014. https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2026/ministerio-da-saude-atualiza-procedimentos-hemoterapicos-e-anvisa-orienta-periodo-de-transicao

4. Secretaria da Saúde do Paraná: orientações sobre a nova Portaria. https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Nova-portaria-para-doacao-de-sangue-entra-em-vigor-nesta-quarta-feira-no-Parana
5. Hemocentro Unicamp: critérios para doação (já com os prazos novos). https://www.hemocentro.unicamp.br/perguntas-frequentes/criterios-para-doacao-de-sangue/
6. HEMOES (Espírito Santo): quem pode e quem não pode doar (prazos antigos em 19/10/2026). https://hemoes.es.gov.br/quem-pode-e-quem-nao-pode-doar
7. HEMOCE (Ceará): dúvidas frequentes (prazos antigos em 19/10/2026). https://www.hemoce.ce.gov.br/servicos/espaco-do-doador/doacao-de-sangue/duvidas-frequentes/
8. Portaria MS nº 158/2016 (regra anterior). https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2016/prt0158_04_02_2016.html
9. AABB: Donor History Questionnaire v4.0 e materiais (questionário, lista de medicamentos, fluxogramas). https://www.aabb.org/news-resources/resources/donor-history-questionnaires/blood-donor-history-questionnaires
10. FDA: orientação sobre o uso do DHQ v4.0 (maio/2023). https://www.fda.gov/media/124193/download
11. Canadian Blood Services: questionário do doador. https://blood.ca/node/364
12. Lifeblood (Austrália): tatuagem e piercing. https://www.lifeblood.com.au/faq/eligibility/lifestyle-and-identity/tattoo-or-piercing
13. NHSBT (Reino Unido): coluna “Ask the Experts”, primavera de 2022. https://www.blood.co.uk/news-and-campaigns/the-donor/latest-stories/ask-the-experts-spring-2022/
14. OMS (2012): Blood donor selection, guidelines on assessing donor suitability for blood donation (ISBN 978 92 4 154851 9); cópia lida em: https://www.notifylibrary.org/sites/default/files/WHO%20Guidelines%20for%20blood%20donor%20selection.pdf
15. Teletriagem no Hospital Israelita Albert Einstein (Hematol Transfus Cell Ther, 2021). https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8530607
16. Vieira e outros, Triagem clínica do processo de doação de sangue: análise da recusa dos doadores (Rev. enferm. UFPE, 2015). https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/10355
17. LGPD, Lei 13.709/2018, Art. 11 (cópia consultada). https://lgpd-brasil.info/capitulo_02/artigo_11
18. Hemovida: notícia sobre o aplicativo do Ministério da Saúde. https://www.itatiaia.com.br/politica/governo-lanca-hemovida-aplicativo-para-facilitar-doacao-de-sangue/